

07 - 07- Maladie Trophoblastique Gestationnelle - Pr. SOUMMANI

Bonjour, le cours d'aujourd'hui va s'intéresser à la maladie trophoblastique gestationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire la maladie trophoblastique gestationnelle ? Sous ce vocable sont réunis un certain nombre d'entités comportant une prolifération trophoblastique d'origine gravidique. Ça veut dire que toute pathologie du trophoblaste d'origine gravidique constitue la maladie trophoblastique gestationnelle.

Et par conséquent, il y en a plusieurs. Il y a la plus classique, la plus fréquente, c'est la molle idatiforme ou molle complète. Il y a également la molle partielle, appelée également syndrome triploïde.

Et il y a la maladie trophoblastique gestationnelle persistante, qui est la molle invasive, le choriocarcinome et des rares cas de tumeurs du site placentaire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Toutes ces pathologies ont en commun, premièrement, une prolifération trophoblastique. Deuxièmement, un marqueur biologique qui est le bêta-ACG.

Bêta-ACG, c'est-à-dire la branche bêta de l'hormone gonadotrophie chorionique. Elles sont en général de bons pronostics. On va parler d'abord de la molle idatiforme.

Qu'est-ce que ça veut dire la molle idatiforme ? C'est une dégénérescence kystique des villosités choréales. Toutes les villosités choréales vont dégénérer et deviennent des kystes. C'est une dégénérescence complète, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'autre structure que la dégénérescence kystique.

Et cette molle idatiforme peut évoluer vers la maladie trophoblastique gestationnelle persistante, qui est soit le choriocarcinome, le choriocarcinome c'est un cancer, et la molle invasive, où il n'y a pas d'anomalie cytonucléaire comme dans le cancer, mais c'est une molle qui a un pouvoir invasif. On ne va pas parler des cas de choriocarcinome ovarien primitif qui n'a rien à voir avec la pathologie trophoblastique gestationnelle. Sur le plan épidémiologique, la molle idatiforme est assez fréquente, 0,5 à 2,5 pour 1000 grossesses, c'est en fonction des pays.

Aux Etats-Unis, c'est 1 grossesse sur 2000, c'est-à-dire 0,5 pour 1000 grossesses. En Asie, surtout en Indonésie, la fréquence est très élevée, on a une molle idatiforme pour 85 grossesses. Le taux en général est bas dans les pays industrialisés, il est élevé dans les pays pauvres.

Les facteurs de risque sont essentiellement l'âge maternel. C'est en général les âges extrêmes, soit avant 20 ans où le risque relatif de molle idatiforme est de 1,5, soit après 45 ans où le risque relatif est au-delà de 25. La race la plus touchée est la race asiatique.

Quelques facteurs nutritionnels tels que la carence en graisse, la carence en carotéine, la multiparité, les antécédents d'avortement, les antécédents de grossesse gemellaire et les antécédents personnels ou familiaux du molle idatiforme. On a également invoqué le rôle du

vieillessement ovocitaire dans cette pathologie qui corrobore avec un âge maternel élevé au-delà de 45 ans quand le risque relatif est de 25 ans. Sur le plan anatomopathologique et cytogénétique, la molle idatiforme a deux entités qui sont différentes.

Différentes sur le plan clinique, différentes sur le plan morphologique et différentes sur le plan cytogénétique. La molle idatiforme ou molle complète, sur le plan anatomopathologique, on a un produit de conception constitué uniquement de vésicules avec une hyperplasie trophoblastique diffuse. Tout le produit de conception est remplacé par des vésicules et une hyperplasie trophoblastique.

Donc, on ne va pas voir de villosité coréale normale. On ne va pas voir de cavité amniotique et, bien entendu, on ne va pas voir d'embryon. Voilà un produit de conception d'une molle idatiforme.

Vous voyez que c'est ce qu'on appelle classiquement l'aspect en grappe de raisin. Donc, tout le produit de conception est transformé en vésicule. Voilà à forme grossissement.

Sur le plan cytogénétique, la molle idatiforme complète est caractérisée par le fait que c'est un caryotype qui est diploïde, c'est-à-dire un caryotype qui est normal. Le plus souvent, dans 96%, c'est un caryotype diploïde XX. Mais, il a une particularité, c'est que c'est un caryotype diploïde androgénique, d'origine androgénique, c'est-à-dire d'origine paternelle, comme si le noyau maternel n'existait pas.

C'est ce qu'on appelle la diandrie. Un spermatozoïde en réplication chromosomique qui va féconder un nouveau site sans noyau. Il y a, dans des rares cas, 4%, le caryotype est normal, diploïde normal, mais du type XY.

Également, d'origine exclusivement paternelle. Ce qu'on appelle la dyspermie, c'est-à-dire un nouveau site sans noyau, un nouveau site anucléé, qui va être fécondé par deux spermatozoïdes. Voilà la fécondation monospermique diandrie.

Donc, un seul ovocyte, un seul spermatozoïde qui va le féconder. Et après, il y a disparition du noyau ovocyttaire, et il y a une réplication de spermatozoïde qui va donner un deuxième chromosome. Donc, on aura un caryotype normal XX, d'origine entièrement paternelle.

La fécondation dyspermique, c'est un nouveau site anucléé, il n'y a pas de noyau qui va être fécondé par deux spermatozoïdes. Dans la molle partielle, ce qu'on appelle le syndrome triploïde. Sur le plan anatomopathologique, comme son nom l'indique, c'est une molle partielle.

Donc, le placenta va être le siège d'une transformation vésiculaire de villosité coréale. Donc, vous aurez une partie du placenta qui va subir une transformation vésiculaire, et le reste va rester normal. Donc, vous aurez une cavité amniotique.

Vous aurez des structures foetales, des structures embryonnaires, mais malheureusement, puisque c'est un triploïde, c'est un syndrome triploïde, vous aurez des malformations foetales.

Sur le plan cytogénétique, c'est entièrement différent de la molle idatiforme ou complète. Dans ce cas, on a un triploïde, c'est-à-dire un nouveau site, un 23ème chromosome, d'origine maternelle, donc 23X, qui va être fécondé par deux spermatozoïdes.

Donc, vous aurez 69 chromosomes, soit XXY, XXX ou XYY, donc 1X plus, éventuellement, la nature des autres spermatozoïdes, soit X, soit Y. Voilà le syndrome triploïde. C'est un nouveau site avec un noyau qui va être fécondé par deux spermatozoïdes. Donc, vous aurez 69 chromosomes.

L'étude clinique, on va s'intéresser au type de description de la forme complète, c'est-à-dire une molle idatiforme complète, puisque c'est la plus fréquente. Sur le plan fonctionnel, c'est une patiente en période d'activité génitale qui va se présenter en consultation ou aux urgences pour des météoragies du premier trimestre de la grossesse. Ce sont des météoragies qui sont faites du sang rouge plus ou moins abondant et qui s'accompagnent de douleurs pelviennes type expulsives, c'est-à-dire comme si l'utérus se contracte.

Il y a également une exagération des signes sympathiques de grossesse. Vous avez vu les signes sympathiques au cours de la grossesse. Les nausées, les vomissements, la somnolence, l'hypersialorrhée, ce sont des signes qui existent dans la grossesse normale.

Ici, ils sont exagérés. Vous pouvez même avoir un syndrome de toxémie gravidique, une pré-éclampsie, très tôt au premier trimestre de la grossesse. Pourquoi ? Parce que nous allons voir que la molle idatiforme est une grossesse anormale, mais hyper active.

Il sécrète trop d'hormones de la grossesse. Les signes généraux peuvent avoir un caractère, peuvent avoir une altération de l'état général puisque les vomissements sont des vomissements incohérents qui existent au cours de la grossesse. Sur le plan physique, donc plus touché, vaginal, si vous mettez votre spéculum, vous trouvez que le saignement provient du col de l'utérus, donc c'est un saignement ondo-utérin, vous faites votre toucher vaginal, et vous allez trouver un utérus qui est augmenté de volume.

C'est-à-dire, si vous avez une grossesse de 7-8 semaines, vous aurez un utérus de taille d'une grossesse de 13-14 semaines. Et à côté de l'utérus, vous allez voir des masses latérales utérines, ce sont en général des cystes ovariens lutéiques, des cystes lutéiniques, puisque j'ai dit que la molle idatiforme est hyper active, donc il va stimuler les ovaires et nous aurons des cystes lutéiques. Voilà.

Grosso modo, c'est une patiente en période d'activité génitale qui va se présenter pour des météoragies du premier trimestre de la grossesse, associées à des douleurs type expulsives, avec une exagération de signes sympathiques de grossesse, avec une augmentation de la taille de l'utérus, et avec des masses latérales utérines. Dans cette étape, vous allez suspecter une molle idatiforme. De toutes les manières, les météoragies du premier trimestre de la grossesse,

on doit évoquer soit une molle idatiforme, soit une grossesse extra-utérine, soit un avortement ou une menace d'avortement, soit bien sûr une lésion cervicale ou vaginale.

Donc, vous allez demander des examens complémentaires. Le premier, c'est l'échographie pelvienne, puisque j'ai dit toujours que l'échographie pelvienne, pour le gynécologue, c'est une continuation de l'examen physique. L'échographie pelvienne va vous montrer un aspect classique de flocons de neige qui est caractéristique de la grossesse molaire, de la molle idatiforme.

Vous n'allez pas trouver de structure embryonnaire, il n'y a pas d'embryon, et vous allez trouver des images latérales utérines, multiloculaires, qui sont bilatérales et qui font rapport avec des kystes luthéenniques. Après l'échographie pelvienne, le deuxième examen est le bêta-ACG plasmatique. Les bêta-ACG plasmatiques, ils ont un rôle primordial, parce qu'ils permettent d'abord le diagnostic, mais également, ils vont servir d'éléments de surveillance de la grossesse molaire ou molle idatiforme.

Vous allez demander une radio de thorax face, éventuellement, à une échographie hépatique, puisque la molle idatiforme, même si elle est bénigne, elle peut métastasier. On peut avoir des métastases au niveau du poumon, au niveau du foie. Les bêta-ACG plasmatiques, en général, dans la molle idatiforme complète, ils sont trop élevés par rapport à la gestationnelle, donc ils sont au-delà de 150-200 000 unités.

Donc, métrorragie, premier trimestre de grossesse, utérus augmenté de taille, masse latérale utérine, aspect enflouant de neige, absence de structure embryonnaire, éventuellement image latérale utérine, associé à un taux de bêta-ACG trop élevé, vous avez le diagnostic de la molle idatiforme. Donc, en général, ça va vous suffire pour poser votre diagnostic. Voilà un peu ce que vous allez voir, une image hétérogène en nid d'abeille, à l'intérieur, au niveau de l'utérus.

Donc, en général, si vous avez cet aspect avec des métrorragies, avec des bêta-ACG trop élevés, c'est une molle idatiforme. Quelques formes cliniques, et nous allons parler de la molle partielle. J'ai dit, bien que la molle partielle, c'est comme la molle idatiforme complète, seulement ici, c'est une partie qui est transformée en vésicule.

Et j'ai dit, bien sûr, que la molle partielle, c'est un syndrome triploïde. Donc, en général, si vous n'avez pas un examen cytopathologique qui parle de syndrome triploïde, vous ne pouvez pas dire que c'est une molle partielle. Le tableau clinique, en général, c'est un tableau comme celui d'un avortement.

Un avortement ou une grossesse arrêtée. Malheureusement, les bêta-ACG, contrairement à la molle idatiforme où le taux de bêta-ACG est trop élevé, ici, le taux de bêta-ACG n'est pas trop élevé, il peut même être négatif. C'est une grossesse qui n'est pas très active comme la molle idatiforme.

L'échographie pelvienne va vous montrer du structure embryonnaire. Donc, vous êtes entre une

grossesse arrêtée et une grossesse molaire partielle. L'évolution, en général, ici, est favorable.

Contrairement à la molle idatiforme qui peut évoluer vers le coriocarcinome et la molle invasive, dans la molle partielle, exceptionnellement, il y a une évolution défavorable vers ces deux pathologies. Il y a également les molles idatiformes compliquées. Hyperthyroïdie, troubles respiratoires, des métastases pulmonaires, des troubles de l'hémostase, et bien sûr, bien entendu, l'évolution anormale vers le coriocarcinome ou la molle invasive.

Quelques diagnostics différentiels. Ce que j'ai dit, si vous avez une hémorragie du premier trimestre de la grossesse, c'est soit une molle idatiforme, soit une grossesse extra-utérine, soit un avortement, sans oublier les lésions locales, c'est-à-dire une lésion cervicale ou une lésion vaginale. Donc, mettez toujours votre spéculum avant de dire que c'est une GU, avortement ou grossesse molaire.

Sur le plan échographique, l'image, ça peut être soit un fibrome en necrobiose, ça donne pratiquement les mêmes aspects, soit une dégénérescence hydropique d'une grossesse arrêtée. Mais dans ces deux cas de figure, fibrome en necrobiose, dégénérescence hydropique, dans les fibromes en necrobiose, les bêtas ASGC sont négatives, dans la dégénérescence hydropique, les bêtas ASGC sont soit négatives, soit ils sont positifs, mais pas à des taux trop élevés comme dans la molle idatiforme complète. Le traitement.

Une fois que vous avez fait le diagnostic, vous devez faire une aspiration. L'aspiration utérine se fait sous anesthésie générale, avec ce qu'on appelle la sonde de Carman, c'est une sonde en plastique et obligatoirement sous perfusion de cytosique. Faites attention, parce qu'il y a des complications qui sont fréquentes, qui sont la perforation utérine, les hémorragies, éventuellement les infections, mais avec les antibiotiques on n'a plus cette complication.

Mais c'est surtout les perforations, parce que l'utérus est très fragile, l'utérus contenant une molle idatiforme est trop fragile, donc ça peut se perforer. Il y a également l'hémorragie, donc il faut toujours avoir un groupe sanguin de la patiente réservé au niveau du centre de transfusion du sang, surtout dans les groupes qui sont rares. Les groupes sanguins bien sûr qui sont rares.

Après l'aspiration, vous devez, si la femme a un résultat négatif, il faut injecter le sérum anti-D parce que la molle idatiforme c'est d'origine paternelle, donc si la femme a un résultat négatif et son mari a un résultat positif, il y a des antigènes D positifs, donc il faut faire attention, donner des antibiotiques, et obligatoirement un contrôle échographique de la vacuité de l'utérus. Ça veut dire quoi ? Une fois que vous avez aspiré, il faut que l'utérus soit vide, parce que j'ai dit que les bêta-ASSG c'est l'élément de surveillance, donc si vous avez laissé un tout petit fragment de la molle au niveau de l'utérus, vous aurez toujours un taux de bêta-ASSG élevé, et vous aurez du mal à dire est-ce que c'est une rétention de la molle, ou bien une évolution anormale vers la maladie trophoblastique gestationnelle persistante, coriocarcinome ou molle invasive. Bien entendu, le produit que vous avez aspiré doit être lavé, et doit être envoyé à l'anatome

pathologiste.

Après le traitement, vous devez surveiller. La surveillance est d'abord clinique, vous aurez progressivement une disparition de saignements, vous aurez progressivement une involution de l'utérus, qui va diminuer progressivement de volume, et s'il y avait des masses latéraux utérines avant l'aspiration, vous allez trouver une régression de ces masses latéraux utérines. Sur le plan radiologique, s'il y avait des métastases, ils peuvent disparaître, et c'est surtout l'échographie qui va montrer une vacuité, vous devez être sûr qu'il y a une vacuité de l'utérus, et qu'il y a une disparition des glycyténines, c'est-à-dire disparition des régressions des images latéraux utérines.

Mais, un moyen, je l'ai dit et je le répète, c'est un moyen biologique, le bêta-ACG plasmatique. D'abord, il faut mettre la patiente sous contraception. Pourquoi ? Parce que si cette patiente tombe enceinte, vous aurez du mal à savoir est-ce que les bêta-ACG sont dus à une complication de la molécule d'antiforme, ou bien c'est un taux de bêta-ACG qui s'est élevé parce que la femme est tombée enceinte, donc la femme doit être mise sous contraception.

Le rythme, en général, c'est un dosage hebdomadaire, c'est un dosage, c'est pas uniquement de dire qu'il y a, mais il faut avoir un taux de bêta-ACG jusqu'à négativation. Donc vous faites chaque semaine un dosage de bêta-ACG et en général, lorsque le taux devient négatif, vous devez faire trois autres dosages pour passer à un dosage mensuel pendant une année, puis un dosage trimestriel pendant la deuxième année. Il faut dire que c'est à vous de voir parce que parfois, vous avez des gens qui n'ont pas les moyens de faire des dosages mensuels pendant une année, mais ça, c'est en fonction, c'est à vous de voir comment régler, comment agir.

Personnellement, je peux faire un dosage chaque deux mois ou chaque trois mois en fonction de la femme. De toutes les manières, la femme doit avoir son dosage négatif, son dosage de bêta-ACG négatif à partir de la douzième semaine. Donc s'il y a une décroissance et une négativation jusqu'à la douzième semaine, c'est bon, donc la femme n'est plus... Il faut juste la surveiller.

Il y a des femmes qui vont avoir une décroissance puis une stagnation, mais ça ne se négative pas. Dans ce cas, c'est anormal. Il y a des femmes qui vont avoir une décroissance du taux de bêta-ACG puis une réascension.

Également, ce n'est pas normal. Une femme qui a un plafond, ça ne disparaît pas. Ça, il faut d'abord chercher s'il y a une... Dans ces trois, c'est-à-dire décroissance puis stagnation, décroissance puis réascension, et l'évolution en plateau du taux de bêta-ACG dans ces trois cas, il faut s'assurer que l'utérus est vide et ça définit ce qu'on appelle la prolifération trophoblastique gestationnelle persistante.

Prolifération trophoblastique gestationnelle persistante, c'est soit un coriocarcinome, soit une molle invasive, soit une tumeur du site qui sont rares. Donc surtout le coriocarcinome et la molle invasive. Voilà un peu l'évolution de bêta-ACG.

Ça se négative en général au bout de 10, 11, 12 semaines. Voilà dans le centre de référence de Lyon comment on fait la surveillance de bêta-ACG. Voilà un aspect de coriocarcinome au niveau de la cavité de l'utérus sur une pièce d'hystérectomie.

Voilà les différentes circonstances de découverte d'une maladie trophoblastique gestationnelle persistante. Le plus souvent, vous avez une patiente que vous suivez qui a une molle d'atypore, vous avez une évacuation, une aspiration utérine et vous surveillez le taux de bêta-ACG. C'est le plus souvent, dans 60% des cas.

Parfois, c'est une femme qui a des météorologies inexpliquées après un avortement. Dans d'autres cas plus rares, c'est des météorologies inexpliquées suite à un accouchement normal ou une grossesse extra-utérine, dans 10% des cas. Dans ces trois éventualités, vous aurez soit un coriocarcinome, une molle invasive ou une tumeur de site d'implantation.

Comment vous allez faire le diagnostic ? C'est en demandant le bêta-ACG. Sur le plan clinique, les circonstances de diagnostic, j'ai dit que c'est soit des météorologies, soit une évolution anormale du taux de bêta-ACG, vous êtes en train de surveiller une femme qui a une molle qui vous avait aspirée, soit carrément, la femme va se présenter avec des métastases, métastases voisinales, pulmonaires, pelviennes, hépatiques cérébrales. L'examen au spéculum, c'est des météorologies.

Et en général, l'utérus est de taille normale. Parfois, vous allez trouver des masses latérales utérines. Mais surtout, le taux de bêta-ACG que vous allez demander chaque fois que vous avez des météorologies inexpliquées après un événement gravidique, que ce soit grossesse extra-utérine, que ce soit avortement, que ce soit grossesse molaire, que ce soit grossesse extra-utérine.

Le taux de bêta-ACG n'a pas ici que la valeur diagnostic, mais il a également une valeur pronostique lorsque le taux est au-delà de 100 000 unités par litre. C'est du mauvais pronostic. L'évolution, l'échographie, vous allez la demander d'abord pour éliminer une grossesse, parce que le taux de bêta-ACG est élevé, ou bien parce que vous avez oublié un fragment molaire, une rétention molaire, ou bien vous allez le faire pour voir le degré d'invasion de miomètre, surtout devant la molle invasive.

L'hystéroscopie avec une biopsie pour l'étude anatomopathologique, si vous avez de la chance, rarement on a de la chance d'avoir un diagnostic histopathologique, c'est rare qu'on a ça. Le curtage biopsique de l'endomètre, si vous allez le faire, il faut le faire avec précaution, parce qu'il y a le risque de perforation du virus. Ici on est dans la maladie trophoblastique gestationnelle persistante, c'est-à-dire coriocarcinome et molle invasive.

Donc vous êtes dans le versant du cancer, et par conséquent il faut faire un bilan d'extension, examen général, spéculons pour voir s'il y a une métastase vaginale, le toucher vaginal pour voir

s'il y a une masse ovarienne. Sur le plan A, paraclinique, également le bilan d'extension, radios de thorax, échographie abdominale, IRM, tomodensitométrie abdominale et thoracique. Il y a une classification de la Fédération internationale de gynécologie obstétrique.

Stade 1 c'est limité à l'utérus, stade 2 c'est au-delà de l'utérus mais toujours au niveau du pelvis, stade 3 c'est les métastases pulmonaires, et le stade 4 c'est les autres types de métastases. Donc les métastases hépatiques sont considérés comme stade 4, les métastases pulmonaires sont considérés comme stade 3. Le traitement, vous n'aurez que moyen thérapeutique, la chirurgie, hystérectomie, la chirurgie hépatique s'il y a une métastase hépatique, la chirurgie cérébrale s'il y a une métastase cérébrale. Mais il faut retenir que même le choriocarcinome, qui est un cancer, même la molle invasive, qui a un pouvoir invasif très élevé, sont des tumeurs qui sont très chimio-sensibles.

Donc vous n'aurez que rarement besoin de la chirurgie. Le plus souvent c'est une chimio-thérapie, soit une mono-chimio-thérapie à base de méthotrexate ou d'actinomycinité, soit une chimio-thérapie à base d'une poly-chimio-thérapie, c'est-à-dire plusieurs drogues anti-mythotiques qui sont réunies. Ici en général c'est des malades qui sont présentés dans le staff des réunions de concertation pluridisciplinaire.

Donc la décision doit être prise entre l'anatomopathologiste, le gynécologue obstétricien, l'oncologue et le radiologue. En général, la surveillance, c'est une surveillance clinique et une surveillance par les bêta-ACG. Le pronostic est relativement bon jusqu'au stade 3, c'est-à-dire même les métastases pulmonaires c'est 100% de survie à 5 ans.

Le stade 4 en général est de mauvais pronostic, mais actuellement avec la poly-chimio-thérapie, on arrive à résoudre le problème.